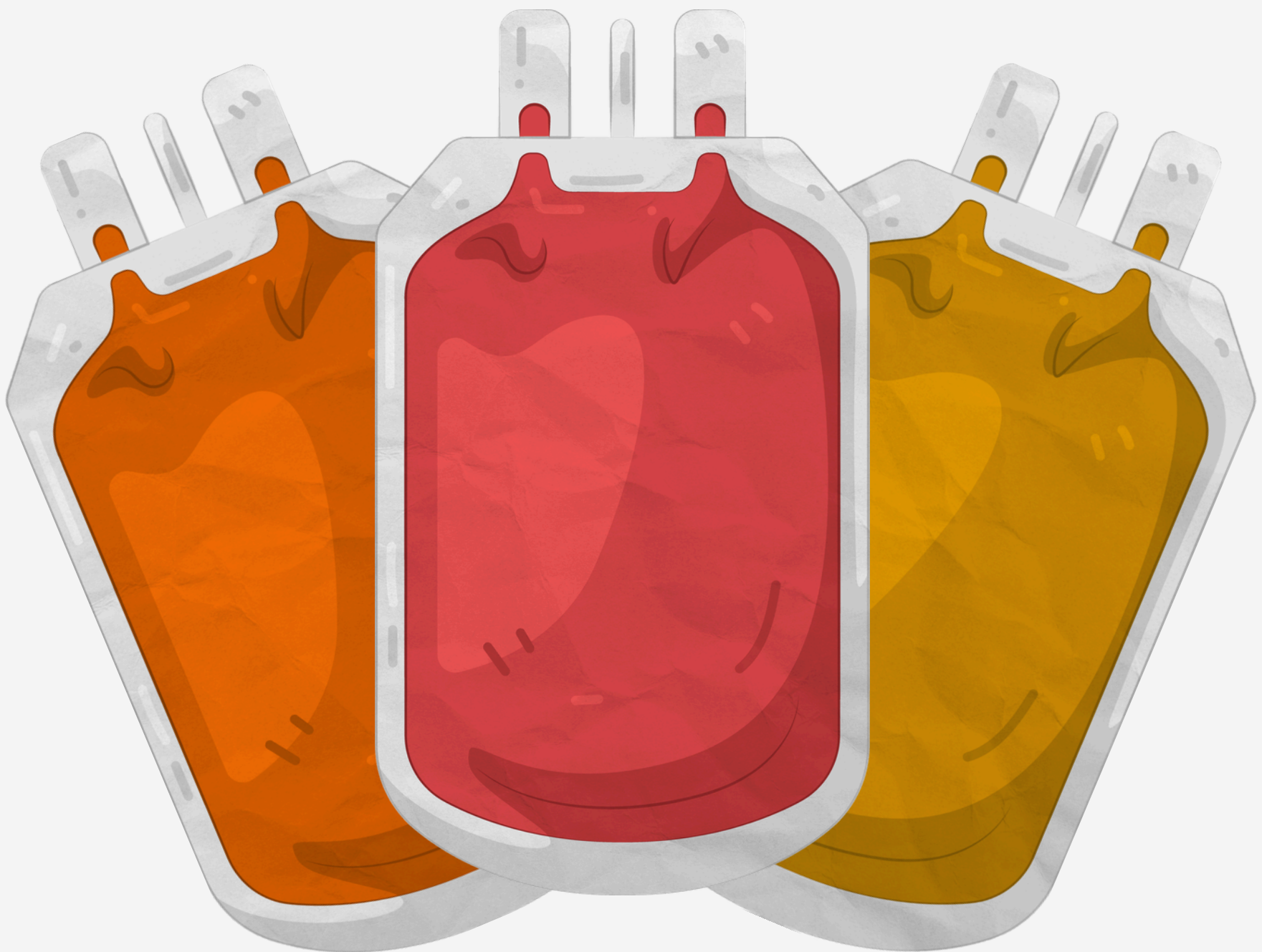


Transfusion

PSL



@CESIREVISE

Introduction

La transfusion sanguine concerne 3 produits :

- **Les Culots globulaires rouges (CGR)**
- **Les concentrés de plaquettes**
- **Le plasma frais congelé**

PSL = produits sanguins labiles = CGR / plaquettes / plasma

MDS = médicaments dérivés du sang = albumine

Indications pour la transfusion de plaquettes :

- **En prévention d'une thrombopénie**
- **Thérapeutique si thrombopénie car induit risque hémorragique**

Indications pour la transfusion de plasma :

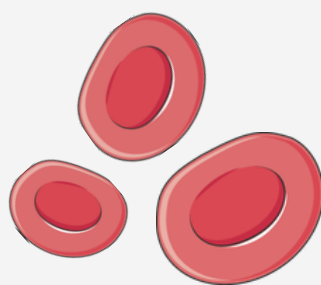
- **En cas de coagulopathie ou purpura thrombocytopénique thrombopathique (PTT)**
- **Thérapeutique si thrombopénie car induit risque hémorragique**



CGR

Les hématies sont des cellules anucléées, qui ont une durée de vie de **120 jours**, qui sont ensuite détruites dans la rate

Elles permettent le transport de l'O₂ via **l'hémoglobine**



La transfusion de CGR est indiquée en cas d'anémie, certains signes cliniques comme une pâleur, fatigue, essoufflement à l'effort peuvent nous mettre sur la voie d'une anémie

hémoglobine : Hb

HOMME	FEMME
14 - 17 g/dL	12 - 16 g/dL

Lorsque le taux de Hb est inférieur à 8 g/dL l'anémie doit être traitée rapidement

1 CGR augmente de 1 g l'hémoglobine



Sécurité

La sécurité transfusionnelle est primordiale, il est donc important de respecter les règles immuno-hématologiques

Groupe : Le système ABO :

- A** Possède des antigènes A + des anticorps B dans le plasma
- B** Possède des antigènes B + des anticorps A dans le plasma
- AB** Possède des antigènes A / B + sans anticorps dans le plasma
- O** Pas d'antigènes + des anticorps A / B dans le plasma

Le O est donc donneur universel de **sang** car il n'a aucun antigène

Le AB est donc donneur universel de **plasma** car il na aucun anticorps

Si mauvaise compatibilité ABO risque d'hémolyse un accident transfusionnel

GR = antigènes / Plasma = anticorps



@CESIREVISE

Transfusion

Avant la commande :

- Réalisé 2 déterminations du phénotype érythrocytaires ABO (2 prises de sang différentes pour l'hémovigilance)
- Recherche d'agglutinines irrégulières = RAI

Les RAI doivent être négatives et datée de moins de 72h

Avant la pose :

- Identitovigilance / hémovigilance
- Un médecin doit être présent dans le service
- Constantes : pouls / TA / Sat / T°
- Produits : aspect, intégrité, date et heure de péremption, à perfuser dans les **6h** après la réception
- Contrôle Immunologique Ultime (CIU) à faire au lit du patient

Ne jamais apporter au patient ce qu'il n'a pas



Transfusion

Après la pose :

Une fois le culot posé, il est obligatoire de rester avec le patient en reprenant les constantes toutes les 5min pendant 15min, puis ensuite revenir 1 fois toutes les 30min pour être sûr que le patient va bien

Calculs & débits

Débit : 1h-1h30 pour les patients sans comorbidités ou contre indication sinon 2h30-3h

1 mL = 15 gouttes



@CESIREVISE